طبع فى 20/10/2026 12:05:06

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : انعام جودة سليمان --

المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** الخانكه **العنوان :** القلج مركز الخانكة القليوبية

رقم البطاقة : 24011241400703 **رقم التليفون :** 01008116974 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 24-11-1940 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(--------------------------)

المقر بما فيه
التوقيع:(--------------------------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي الاورام المنتشر [14456]

قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

G R I - E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** -------------------------- د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** -------------------------- ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** -------------------------- نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ---

خطة العلاج : ---

المستشفي : --- **قسم :** ---

جهة العلاج : -- **نفقات :** ---

ملاحظات : ---

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: -- انعام جودة سليمان
National ID: 24011241400703

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

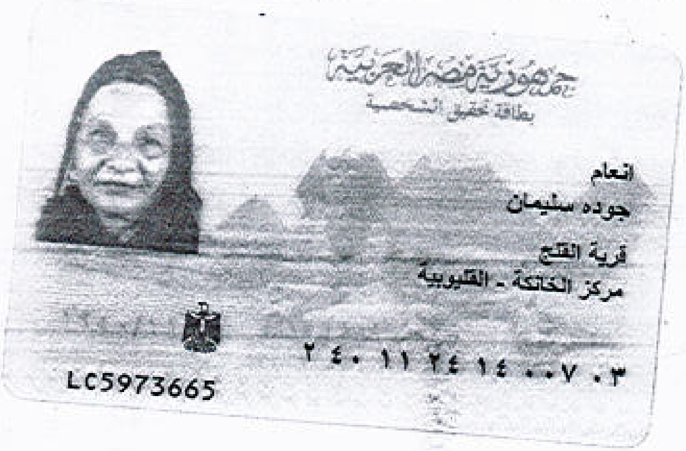
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Pin Medication And Anti Emetics

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



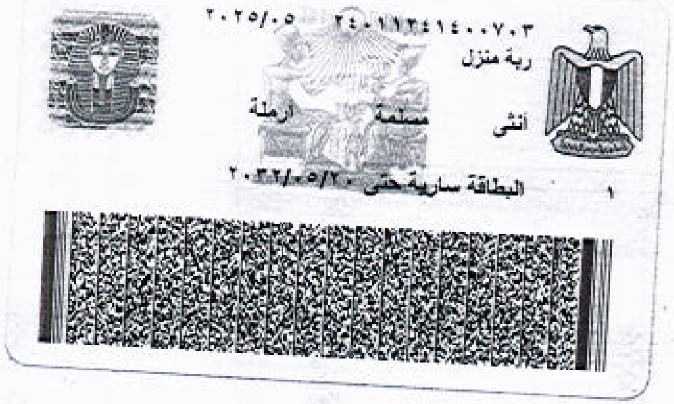
جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

انعام
جوده سليمان

قرية القلج
مركز الخانكة - القليوبية

٢٤٠ ١١ ٢٤ ١٤ ٠٠٧ ٠٣

LC5973665

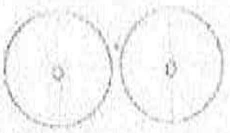


٢٤٠١١٢٤١٤٠٠٧٠٣ ٢٠٢٥/٠٥
ربة منزل
أنثى مسلمة ارملة
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/٢٠

National ID Front & Back (same page)
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MDT form

A-Patient ID
1- Name : [illegible]
Sex: Female
3- Medical number: 53249935
Old MRN: 4365-2024
2-ID number:
Patient Age : 84 Y



Family history: [illegible]
Phone: 01008135973
Marital status: [illegible]
NHS Score: [illegible]
GROUP: [illegible]
Comorbidity: [illegible]
Menopausal status: [illegible]
Onset STAGE: [illegible]
REASON OF MDT: [illegible]
Date of MDT: 22/01/2025

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX IDC	ER 8/8	PR 6/8	Her 2 Neu 2	SISH Amplified	KI67 30

T	N	M 1 LUNG BONE , LN

Sonomammography

PATIENT HISTORY
INITIALLY MBC to bone , LN, lung
PS : 3

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ARIMIDEX + HERCEPTIN IV AFTER ECHO + ZOMETA Q 3 MONTH

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

AIN SHAMS UNIVERSITY

Patient Name: انعام جرجه سليمان 0
MRN: 10210524254027
D.O.B: 24/11/1940
IC No.: 24011241400703
Location: External Clinic
Sex: Female

Surgical Pathology

Specimen

Specimen Id 2410310776
Accession No SU-24-977
Sample Type TISSUE
Collection Date 31/10/2024 11:22 AM
Received Date 31/10/2024 11:22 AM

Specimen

Tru- cut biopsy from left breast mass.

GROSS DESCRIPTION

Three greyish white tissue cores, ranging in length from 1.2cm to 1.5cm.T.E.

Technique

MICROSCOPIC

The examined serial section reveal fibrous tissue cores showing infiltration by cords and nests of malignant epithelial cells displaying moderate degree of anaplasia and poor attempts at acinar formation.
The stroma shows desmoplastic reaction and focal necrosis.

IMMUNOHISTO CHEMICAL RESULT

- ER: Strong positive nuclear staining in about 90% of tumor cells (Allred's score 8/8).
- PR: Weak to moderate nuclear staining in about 40% of tumor cells (Allred's score 6/8).
- Her2neu: Weak to moderate complete membranous staining reaching up to > 10% of tumor cells (equivocal score 2+) for SISH confirmation.
- Ki-67: Proliferative Index 30%.
- E- cadherin: Positive membranous staining of tumor cells.

DIAGNOSIS

Left breast mass, tru-cut:
Invasive mammary carcinoma of no special type(ductal) garde 2.

Responsible pathologist
Prof. Dr. Nermine kortam.
13/11/2024

انعام جرجه سليمان
909343
2024-11-26

Reported and electronically endorsed by
Anatomical Pathology Unit

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: En'aam Goda Soliman	Date : 15/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 84 Year(s)
Medical ID: 4365/2024	Pat ID: 95414

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- **Left breast multiple irregular lesions largest seen involving UOQ & LOQ measures about 7.5 x 4 cm seen invading the nipple and thickened skin.**
- **Multiple left axillary level I & II enlarged lymph nodes largest measuring 1.5 x 1.2 cm.**
- **Few enlaregd left supraclavicular enlarged lymph nodes largest measuring 1 x 0.7 cm.**
- **Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest at left lower lobe posterior segment measuring 1.6 x 1.5 cm.**
- **Few prominent mediastinal and bilateral hilar hyperdense lymph nodes largest at anterior mediastinal / left internal mammary region measuring measuring 1.4 X 1.9 cm some show internal hyperdensity.**
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definte enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Bilateral cortical simple cysts.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.

Patient Name: Enaam Goda Soliman	Date: 16/12/2024
Exam: C T CHEST	Age: 84 Year(s)
Medical ID: 4365/2024	Pat ID: 95414

- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- **Left anterior acetabulum and left pubic bone lytic osseous lesion with associated fracture of the left inferior pubic ramus.**
- **Few scattered vertebral and left iliac wing sclerotic foci and areas are noted.**
- Osteopenic texture of the examined bones.
- Spondylodegenerative changes.

Opinion:

- **Left breast multiple iregular lesions with ipsilateral pathological axillary and supraclavicular lymph nodes.**
- **Few prominent mediastinal and bilateral hilar lymph nodes mostly metastatic.**
- **Multiple bilateral scattered pulmonary nodules likely metastatic.**
- **Multiple osseous lesions as described likely metastatic.**
- **No evidence of hepatic metastatic deposits on non-contrast basis.**

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

ا.د. أحمد كمال البدري
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوي
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

مركز مصر للأشعة
MISR RADIOLOGY CENTER MRC

NAME: EN'AAM GODA SOLIMAN **PATIENT ID: 1219613**
REF. PHY.: DEAR SIR **STUDY DATE: 04/12/2024**

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- 84-year-old female patient presented with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- Enhanced tracer uptake is seen at the right scapula, left sternoclavicular articulation, both sacroiliac articulations, both pubic bones, trochanteric area of left femur as well as mid shaft of both femora.
- DV11 partial collapse (compressed fracture) is noted.
- Osteoarthritic features are observed around most of the big joints.
- Active tracer uptake at the left ureter, for further urological assessment.

IMPRESSION

- Metastatic osseous lesions as described above.
- Follow up bone scan is recommended to monitor therapy response.

Much obliged,
Dr. Mohamed Mashal, MD
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine